

97.8% (135/138)。

两种前列腺按摩法收集的 PS 量及患者的耐受性比较见表 1。其中,采用新法收集的 PS 量明显高于传统法 ($P < 0.01$),患者对新法的耐受性明显高于传统法 ($P < 0.01$)。

表 1 两种前列腺按摩法收集的 EPS 量、患者耐受性比较

分组	例数	前列腺液量(ml)	耐受例数 [n(%)]
传统法组	123	1.231	63(51.2)
新法组	138	2.115*	111(80.4)*

* 与传统法比较 $P < 0.01$

讨 论

本方法的优点为:(1) 让医生位于受检者的侧面并面向患者,便于随时观察患者的反应,从而调整按摩的面积、方向、力度并有效沟通交流以减轻患者的痛苦;(2) 由于医生与患者能够感觉判断第一滴前列腺液的溢出并及时停止操作,从而避免无谓增加患者的痛苦;(3) 由于医生采用直立位姿

势,使医生在操作中更加省力、持久。而最为重要的是与直肠生理角度保持平行,这样,就确保了医生每一次操作都定位准确,按摩有力。如果医生适当掌握推拿的技巧手法则对前列腺按摩有很大帮助。

关键词 前列腺; 按摩

中图分类号 R 697.3

参 考 文 献

- 1 张海峰,王洪亮,李胜文,等.应用 PSA 对 1207 名老年男性进行前列腺癌集团检诊及意义分析.中国男科学杂志 2002;16(3):213-2162
- 2 顾方六主编.现代前列腺病学.北京:人民军医出版社,2002:539-540
- 3 郭应禄,李宏军主编.前列腺炎.北京:人民军医出版社,2002:315-317

(2008-06-24 收稿)

· 男科医生学习园地 ·

磷酸二酯酶 5 (PDE₅) 抑制剂的药理学和药物相互作用: α 受体阻滞剂的相互作用 Am J Cardiol 2005 Dec 26; 96(12B): 42M-46M

目前全球共有 3 种治疗勃起功能障碍的磷酸二酯酶 5 (PDE₅) 抑制剂:西地那非、伐地那非和他达拉非。每种药物对不同病因引起的 ED 均有效,包括男性血管性 ED。PDE₅ 存在于动、静脉系统的血管平滑肌细胞中,PDE₅ 抑制剂是温和的血管扩张剂,能使血压轻微下降(通常是无显著临床意义的)。然而,PDE₅ 抑制剂与硝酸盐具有协同降低血压的作用(包括收缩压和舒张压),因此这 3 种药物禁用于使用硝酸酯类的患者。Kloner RA 对此作了一项综述性研究。PDE₅ 抑制剂与硝酸盐类药物间相互影响的持续时间取决于研究药物本身。西地那非或伐地那非与硝酸甘油间的相互作用仅在 24h 内可观察到。一项研究发现,西地那非和舌下含服硝酸甘油相互作用仅在 4h 内可观察到。而他达拉非给药后 48h 仍可观察到其与硝酸甘油间的相互作用,这与该药物半衰期较长有关。当服用大多数抗高血压药物(例如 β 受体阻滞剂、血管紧张素转换酶抑制剂、血管紧张素受体拮抗剂、钙通道阻滞剂和利尿剂)的高血压患者使用 PDE₅ 抑制剂时,通常会有轻微的额外的血压下降,但副作用并没有明显增加。当 PDE₅ 抑制剂与 α 受体阻滞剂(主要是治疗高血压或泌尿系疾病如良性前列腺增生的药物)联用时,部分患者发生体位性低血压。在使用 3 种 PDE₅ 抑制剂前,必须事先告知患者这些潜在的相互作用。有些研究认为,当患者长期接受 α 受体阻滞剂治疗时,这种相互作用的临床重要性相对较低。有些分析认为,与安慰剂对照组或年龄匹配人群的预期结果相比,PDE₅ 抑制剂并不增加心肌梗死的发生率或死亡率。相反,最近有研究表明 PDE₅ 抑制剂可能对相当一部分心血管疾病有潜在的治疗作用。总之,正确使用 PDE₅ 抑制剂有很高的安全性和有效性。

点评:文章从三个方面介绍了如何安全使用 PDE₅ 抑制剂:(1) 不同的 PDE₅ 抑制剂半衰期不同,与硝酸盐类药物相互影响的持续时间不同,提示我们服用半衰期短的西地那非或伐地那非后,可以更早地安全服用硝酸盐类药物;(2) PDE₅ 抑制剂与 α 受体阻滞剂联用时,副作用无明显增加,但是部分患者可发生体位性低血压,应给与警惕;(3) PDE₅ 抑制剂不仅不增加心梗的发生率、死亡率,还可能对部分心血管疾病有潜在治疗作用,可以安全使用。

(首都医科大学附属北京朝阳医院泌尿外科 张 勇 邮编:100020)